

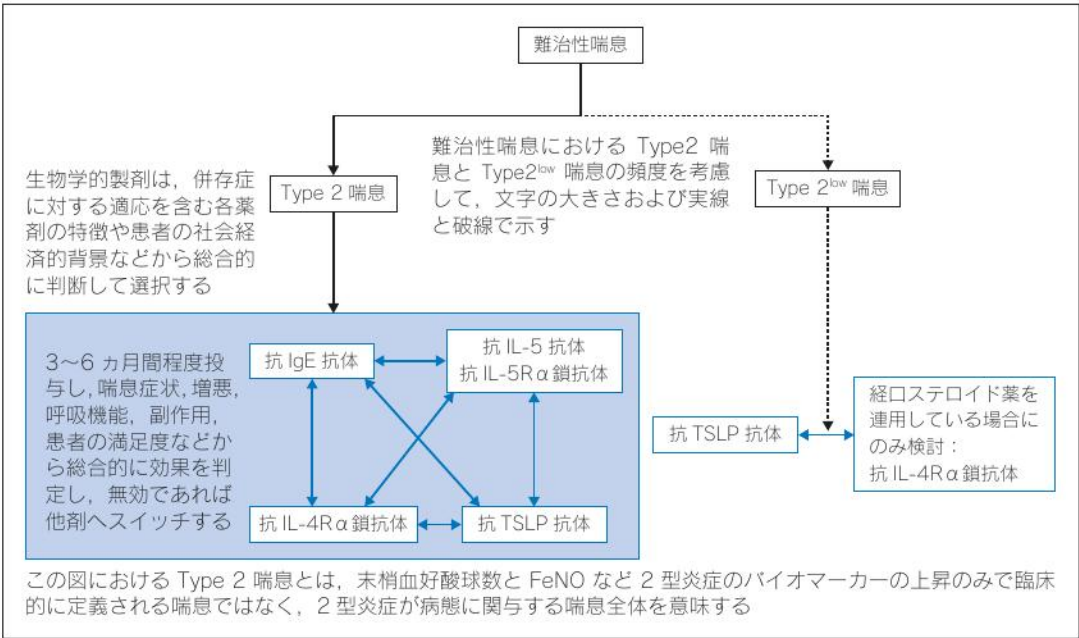


図 5 難治例への対応のための生物学的製剤のフローチャート
[日本アレルギー学会喘息予防・管理ガイドライン 2024WG (監修)：喘息予防・管理ガイドライン 2024, 協和企画, p132, 2024 より許諾を得て転載]

表 11 救急外来受診の目安

- ・中等度（苦しくて横になれない）以上の喘息症状のとき。
- ・ β_2 刺激薬の吸入を 1～2 時間おきに必要とするとき。
- ・症状が悪化していくとき。

[日本アレルギー学会喘息予防・管理ガイドライン 2024WG (監修)：喘息予防・管理ガイドライン 2024, 協和企画, p144, 2024 より許諾を得て転載]

表 12 救急外来での問診で注意すべきポイント

- ・発症の時間と増悪の原因
- ・これまでの服薬状況、最後に使用した薬剤とその時間、およびステロイド薬の使用。
- ・これまでの喘息による入院の有無と救急外来の受診状況。
- ・喘息による呼吸不全や気管挿管の既往の有無。
- ・心肺疾患および合併症の有無（心不全、気胸、肺血栓塞栓症などは特に注意を要する）。
- ・N-ERD（NSAIDs 過敏喘息、AERD、アスピリン喘息）や薬物アレルギーの有無。

[日本アレルギー学会喘息予防・管理ガイドライン 2024WG (監修)：喘息予防・管理ガイドライン 2024, 協和企画, p141, 2024 より許諾を得て転載]

表 13 喘息増悪の強度と目安となる増悪治療ステップ

PEF 値は、予測値または自己最良値との割合を示す。

増悪強度*	呼吸困難	動作	検査値の目安				増悪治療ステップ
			PEF	SpO ₂	PaO ₂	PaCO ₂	
喘鳴/ 胸苦しい	急ぐと苦しい 動くとき	ほぼ普通	80%以上	96%以上	正常	45Torr 未満	増悪治療 ステップ 1
軽度 (小発作)	苦しいが 横になれる	やや困難					
中等度 (中発作)	苦しくて 横になれない	かなり困難 かろうじて 歩ける	60～80%	91～95%	60Torr 超	45Torr 未満	増悪治療 ステップ 2
高度 (大発作)	苦しくて 動けない	歩行不能 会話困難	60%未満	90%以下	60Torr 以下	45Torr 以上	増悪治療 ステップ 3
重篤	呼吸減弱 チアノーゼ 呼吸停止	会話不能 体動不能 錯乱 意識障害 失禁	測定不能	90%以下	60Torr 以下	45Torr 以上	増悪治療 ステップ 4

*：増悪強度は主に呼吸困難の程度で判定する（他の項目は参考事項とする）。異なる増悪強度の症状が混在する場合は強いほうをとる。

[日本アレルギー学会喘息予防・管理ガイドライン 2024WG (監修)：喘息予防・管理ガイドライン 2024, 協和企画, p142, 2024 より許諾を得て転載]